Guía Rápida. Timectomía

MATERIAL ESTERILIZACIÓN

- Toracotomía nº1
- Separador finocheto
- Sierra esternal (striker, aesculap o invatec)
- Caja menor
- Partes blandas de torácica
- Set colon – recto
- Termo
- Hemolock M/L, L y XL
- Caja VATS N2
- Instrumental DV
- Accesorios DV
- Material bolsa dv (pinzas + cables)
- Endoscopio 30º

MATERIAL FUNGIBLE GENERAL:

- Set aorto-abdominal
- Torunditas
- Rotulador
- Drenaje tipo blake nº24 o sonda vesical para extraer el neumo
- Pleurevac (si no hay thopaz) en caso de dejar drenaje
- Vaseloop azul grueso (opcional)
- Específico DaVinci:
    - Posicionador pink-pad (opcional)
    - Fundas de brazo x4
    - Funda de columna
    - Adaptador de 5-8mm x4 (puede hacerse con tres brazos)
    - Obturador 8 mm
    - Sistema neumo airseal
    - Trócar 12mm airseal
    - Aspirador-irrigador elefant 45 cm
    - Vessel sealer
- Específico laparoscopia:
    - Endobolsa pequeña y grande
    - Punta de clinch (x2)
- Jeringa 20ml
- Aguja de carga
- Aguja IM / palomilla azul (si se hace bloqueo durante la cirugía)
- Suturas:
    - Seda 0 aguja triangular (para drenaje)
    - Vicryl 0 y 2-0 (cierre partes blandas)
    - Grapadora

MATERIAL HEMOSTASIA

- Floseal (+ sonda nasogástrica naranja y jeringa 20ml)

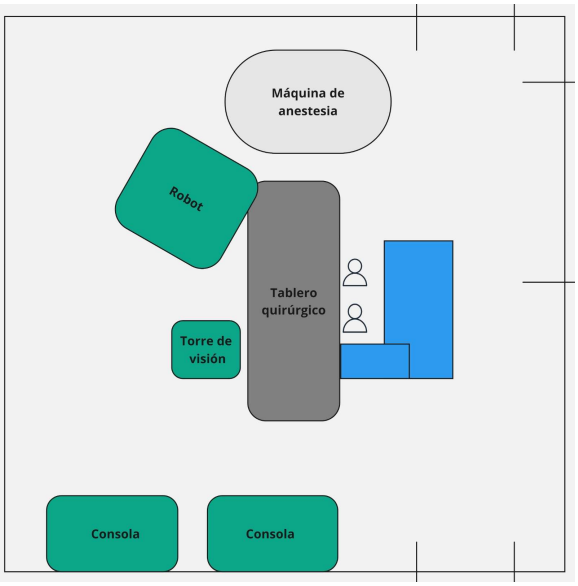
- Surgicel original 10x20cm

MATERIAL ANESTESIA

- Tubo endotraqueal de doble luz (preferiblemente Vivasight)
- Fibrobroncoscopio desechable fino
- Catéter epidural (S/características del paciente y riesgo de reconversión)
- Sistema de arteria
- VVP gran calibre con calentador de líquidos
- VVC (S/características del paciente)
- Sondaje vesical
- Clamp de tubo (en el caso de que no se use tubo vivasight o con clamp incorporado)
- Manta térmica.

POSICIÓN QUIRÚRGICA DEL PACIENTE Y DEL ROBOT

- Decúbito supino, pegado al borde izquierdo del tablero y un cilindro de sábanas o una cuña bajo tórax izquierdo para elevarlo levemente.
- MSD pegado.
- MSI colocado en un apoyabrazos bajo, para que quede por debajo del eje corporal.
- Cinta de sujeción por debajo de la cresta iliaca (opcional)
- Foam o acolchado sobre la cara y el TET si el brazo del robot tuviese riesgo de golpear la zona.
- Robot: anatomía torácica sagital



Enlace a la técnica quirúrgica